Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5030383-95.2021.8.21.0027/RS

AUTOR: LICELIA MARIA PIVETTA

RÉU: UNIMED SANTA MARIA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

LICELIA MARIA PIVETTA ajuizou a presente *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada* em face de **UNIMED SANTA MARIA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, ambas as partes devidamente qualificadas na inicial (evento 1, INIC1). Historiou que é usuária/beneficiária de plano de saúde da parte ré, da modalidade familiar global, desde 09/05/2013. Contou que foi diagnosticada com câncer ovário em 2020 (CID 10 - C56, neoplasia maligna do ovário), já submetida a tratamento oncológico, do tipo cirúrgico e quimioterápico. Narrou que, na sequência ao tratamento quimioterápico realizado em internação hospitalar, houve a prescrição médica de continuidade do tratamento de forma ambulatorial, com administração do medicamento LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB), a qual é de suma importância para continuidade do tratamento oncológico, sendo fundamental para redução da progressão da doença e do risco de morte. Destacou que o referido medicamente é aprovado e registrado pela ANVISA desde 2018. Sustentou que foram encaminhados à demandada a integralidade dos documentos médicos, laudos, atestados e receituário médico prescritivo do referido medicamento, com a solicitação de fornecimento, mas, contudo, esta apresentou negativa, sob o fundamento de que não exista obrigatoriedade de cobertura de medicamento antineoplásico oral, além do argumento de que o medicamento não se encontra no rol das Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimento na saúde suplementar - DUT 64, não havendo portanto, obrigatoriedade no seu fornecimento. Teceu considerações a respeito do tratamento com o referido medicamento e do direito aplicável ao caso em tela. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, determinação para que a demandada forneça ou custeie o remédio LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB) para uso contínuo conforme prescrição médica, na posologia de 2 comprimidos, para 2 vezes ao dia, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Alternativamente, pediu a condenação da demandada ao pagamento dos valores referentes ao custeio anual do tratamento com o medicamente prescrito, pelo período que for necessário, conforme avaliação médica contínua. No mérito, pediu a ratificação do pedido liminar, sendo a ré condenada a prestar o fornecimento do medicamento, LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB). Requereu AJG. Juntou documentos (demais documentos no Evento 1).

Deferida a AJG e o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a ré forneça o remédio LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB) para uso contínuo conforme prescrição médica, na posologia de 2 comprimidos, para 2 vezes ao dia, invertido o ônus da prova, ordenada a citação da parte ré e intimada a parte autora para que junte procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio a documentação requerida (evento 10, PET1).

Citada (evento 8, CERTGM1), a ré ofereceu contestação (evento 13, PET1). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, defendeu que o medicamento reclamado pela autora não consta no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Dissertou sobre a previsão constitucional do direito à saúde e sobre ausência de obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde proverem, por todo e qualquer meio, a prevenção de doenças e o tratamento da saúde dos seus beneficiários. Defendeu a existência de legislação específica sobre a matéria que impõem que os contratos de planos de saúde ofereçam cobertura mínima. Discorreu sobre o contrato havido entre as partes e destacou que na cláusula 35, alínea XXXII, está previsto que a cobertura limita-se ao rol dos procedimentos mínimos editados pela ANS. Falou que o procedimento de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer previsto no rol da ANS possui diretrizes de utilização (DUT - 64), e a medicação solicitada não consta naquele rol, além de tratar-se de medicamento de uso domiciliar. Afirmou que é descabido levar-se em conta unicamente a prescrição médica para fins de condenar os planos de saúde ao fornecimento de medicamento ausente no rol da ANS, bem como alegou que não há que se falar em desvantagem contra o consumidor, visto que deturpa o contratado. Sinalou que o contrato prevê expressamente a ausência de cobertura em casos como o ora verificado. Defendeu que o medicamento que a autora utiliza é de uso domiciliar, caso em que também é excluído da cobertura do plano de saúde, por permissividade do art. 10, VI, da lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa nº 465/2021. Acostou jurisprudências acerca da temática, bem como o posicionamento tomado pelo CNJ, a fim de amparar suas teses. Alternativamente, falou sobre a possibilidade de ser condenada unicamente ao custeamento do medicamento pelo período de 1 (um) ano. Ao final, pediu a análise da preliminar suscitada e a improcedência dos pedidos da inicial, com a revogação da liminar deferida. Juntou documentos (demais documentos no Evento 13).

Houve réplica (evento 18, RÉPLICA1).

Intimadas as partes acerca das questões de fato e de direitos importantes ao julgamento da lide, bem como sobre o interesse na dilação probatória (evento 21, DESPADEC1).

As partes manifestaram-se referindo o desinteresse na dilação probatória (evento 26, PET1 e evento 28, PET1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Julgo o feito antecipadamente (art. 355, inciso I, do CPC/2015), pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do meu convencimento e solução da lide, aliado ao fato de que as partes manifestaram-se pelo desinteresse na produção de novas provas.

Dito isso, passo à análise da preliminar suscitada pela parte ré.

Da impugnação ao valor da causa

Sustentou a parte requerida ser incorreto o valor atribuído à causa, haja vista que, por se tratar de demanda em que o proveito econômico é inestimável, tal montante deveria corresponder ao valor mínimo de alçada.

Pois bem, não procede a irresignação da parte demandada, em que pese a argumentação desenvolvida, uma vez que o proveito econômico da demanda é mensurável, sendo que a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que para a quantificação do valor da causa, deve-se levar em conta os custos referentes a 12 (doze) meses do uso do medicamento.

Nesse sentido:

> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESACOLHIMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. MEDICAMENTOS DRABAFENIBE E TRAMETINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.*
>
> *I. **IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ PRAZO ESPECÍFICO PARA O TÉRMINO DO TRATAMENTO MÉDICO, O VALOR DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DEVE SER IGUAL A UMA PRESTAÇÃO ANUAL, NA FORMA DO §2° DO ART. 292 DO CPC. LOGO, SOMANDO-SE O VALOR DA PRESTAÇÃO ANUAL DOS MEDICAMENTOS AO MONTANTE PRETENDIDO NA PETIÇÃO INICIAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ART. 292, IV E V, DO CPC, CHEGA-SE EXATAMENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA.***
>
> *[...]*
>
> *(TJ/RS. Apelação cível nº 50088853820208210039, Quinta Câmara Cível, Publicação: 26/11/2021, Julgamento: 26 de Novembro de 2021, Relator: Jorge André Pereira Gailhard) **(grifei)***

Assim, consigno que se tratando de demanda em que não há prazo específico para o término do tratamento com a medicação, aplica-se o disposto no § 2º do art. 292 do CPC[1], tomando o valor das prestações vincendas como o valor da prestação anual do medicamento.

Sendo assim, como bem explicou a autora na sua réplica, o valor anual de custeio do medicamento é de R$ 369.200,00 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos reais), ou seja, o valor atribuído à causa.

Dessa forma, o proveito econômico é calculável e, portanto, vai mantido o valor da causa atribuído na inicial.

Mérito

Cuida-se de ação por meio da qual a parte autora alega, em suma, que necessita do medicamento LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB), a qual é de suma importância para continuidade do seu tratamento oncológico, haja vista que foi diagnosticada com câncer ovário em 2020 (CID 10 - C56, neoplasia maligna do ovário). Disse que houve negativa da ré do fornecimento do fármaco, sob o fundamento de que não existe a obrigatoriedade de cobertura de medicamento antineoplásico oral, visto que não se encontra no rol das Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimento na saúde suplementar - DUT 64. Sendo assim, pediu seja a ré compelida a fornecer o referido medicamento necessário para seu tratamento.

Em juízo, a parte demandada reforçou a negativa, ao argumento de que o medicamento não encontra previsão no Rol de Procedimentos da ANS, porquanto não consta na listagem da diretriz nº 64 da ANS, sendo a cobertura faculdade da operadora do plano de saúde, razão pela qual ela pode negá-la sem que sua conduta se configure como ato abusivo.

Inicialmente, consigno que o contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com orientação pacificada, inclusive, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Súmula 608, cujo teor transcrevo a seguir:

> *Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Nesse contexto, consoante redação do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a ré UNIMED é fornecedora de serviços e responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores, sendo que o contrato de seguro plano FR1A (Evento 13), firmado em 09/05/2013, entre a ré Unimed, e a requerente deve ser esquadrinhado sob as normas da Lei nº 9.656/98 e do CDC, motivo pelo qual, inclusive, incidente ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º da Legislação Consumerista[2].

Logo, sinalo, desde já, que a presente demanda procede, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

No caso, trata-se de fato incontroverso que a parte demandada ofereceu negativa de cobertura do medicamento reclamado (evento 1, OFÍCIO/C10), todavia, também restou incontroversa a necessidade do medicamento pela parte demandante e do seu uso contínuo, a fim de que seu tratamento seja bem sucedido (evento 1, LAUDO8).

Sendo assim, como bem aponta a parte ré em sua contestação, tratando-se de demanda em que há conflito derivado do interesse econômico e em que há discussão acerca do direito à saúde da parte demandante, é dever do Juiz analisar cada demanda com a parcimônia e cuidado que lhes é inerente.

Dessa forma, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano e indicada pelo médico especialista.

Nesse sentido, inclusive, é como posicionou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ré questionando a tutela provisória de urgência deferida:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. **APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA 150 MG (OLAPARIBE). NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO.** PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.\n1. CONSOANTE A REDAÇÃO DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.\n2. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, § 2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998.\n3. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10.\n4. **AO MENOS EM ANÁLISE SUMÁRIA, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA DO MEDICAMENTO POSTULADO, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELOS MÉDICOS ASSISTENTES PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE (NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO - CID10 C56), O QUE IMPLICA O RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.**\n5. CUMPRE CONSIGNAR QUE O PERIGO DE DANO ADVÉM DO RISCO DE EVOLUÇÃO DO QUADRO CAUSADO PELA ENFERMIDADE QUE, CONSOANTE INCONTROVERSO, ACOMETE A PARTE AUTORA.\n6. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.\nAGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 52384430920218217000 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022) **(grifei)***

Para mais, há que se destacar que o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a autora, qual seja, o câncer, bem como o tratamento necessário, não podendo haver negativa de cobertura somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória.

Com isso, considerando a imprescindibilidade do fármaco, deve prevalecer a cobertura contratual de modo genérico, sob pena da cláusula ser considerada abusiva ou ser interpretada de forma restritiva à luz do artigo 54 do Código Consumerista.

No mais, como prevê o art. 18, da RN 465/2021, que revogou a RN 428/2017, da ANS, é obrigatório que o Plano de Saúde forneça aos conveniados cobertura de medicamentos antineoplásicos, sejam orais para uso domiciliar ou venosos, *in verbis:*

> *Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:*
>
> *[...]*
>
> *X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:[...]*

Atentem-se as partes que este Juízo não desconhece as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca da temática, o qual formou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é, em regra, taxativo.

Todavia, mesmo após tal relevante precedente, não há que se falar em total desobrigação do custeio de medicamentos não previstos no rol pelos planos de saúde.

Nesse ponto, a Segunda Sessão do STJ fixou as seguintes teses:

> *1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;*
>
> *2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;*
>
> *3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;*
>
> *4. **Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente**, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.[3] **(grifei)***

Ou seja, em situações excepcionais, os planos estão obrigados ao custeio de procedimentos não previstos na lista, quando verificada a ausência de substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, tal como ocorre no caso em apreço, haja vista que a parte demandada não demonstrou a existência de substituto terapêutico com a mesma eficácia, ônus seu, nos termos da tese acima listada.

Assim, em que pese a parte ré faça menção genérica acerca da existência de alternativas medicamentosas com a mesma eficácia para tratamento da doença que acomete a parte autora, não verifico que desincumbiu-se do ônus de provar tal fato, mesmo ciente da inversão do ônus da prova decorrente da incidência das normas da legislação consumerista, conforme determinado na decisão do evento 4, DESPADEC1.

Por outro lado, sinalo que a parte demandante juntou laudo médico que atesta a necessidade de fazer a utilização da medicação Lynparza Olaparibe, 150 mg, com dois comprimidos duas vezes ao dia (evento 1, LAUDO8).

Dessa forma, considerando que os fármacos postulados na exordial foram prescritos pelo médico que trata a demandante, resta configurada a obrigação da administradora do plano de custear os medicamentos, porquanto cabe ao profissional médico prescrever qual o melhor tratamento ao seu paciente, bem como ausente notícia de substituto terapêutico similar.

Por remate quanto a tal ponto, registro que recentemente a Lei n. 14.454/2022, reduziu, grandemente, o alcance da indigitada decisão do STJ, deixando bem mais flexível a possibilidade de o utente de plano de saúde privado ter dispensado tratamento ou procedimento fora do rol da ANS, na medida em que trouxe duas possibilidades (alternativas) para a dita dispensão. Veja-se o teor dos incisos I e II do parágrafo 13. do art. 10 da Lei 9.656/1998.

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Por fim, apenas para não passar em branco, haja vista que ausente quando dos pedidos da contestação, sinalo que não há motivos para o acolhimento da tese subsidiária requerida pela parte ré, consistente na determinação de que custeie o pagamento do medicamento prescrito pelo período de 1 (um) ano, pois, como esboçado alhures, cabe ao médico da autora verificar a necessidade do prosseguimento do tratamento com o medicamento ora reclamado, não podendo este sofrer limitação temporal injustificada.

Destarte, pelas razões expostas, ratifico a tutela provisória de urgência deferida (evento 4, DESPADEC1), sinalando a procedência do pedido lavrado na inicial.

ISSO POSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, **julgo procedente** o pedido lavrado na inicial, para o fim de ratificar a tutela provisória de urgência deferida (evento 4, DESPADEC1) e condenar a ré a fornecer o remédio LYNPARZA 150 mg (OLAPARIB) para uso contínuo conforme prescrição médica, na posologia de 2 comprimidos, para 2 vezes ao dia.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da parte adversa, os quais fixo no percentual de 10% do valor da causa, devidamente corrigido pelo IPCA desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (sem capitalização), este contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, considerando o tempo de duração do processo, o labor do causídico, a natureza e a importância da causa, forte nos art. 85, §§ 2º e 8º, CPC/2015.

Interposto(s) recurso(s) de embargos de declaração, venham conclusos os autos para análise dos pressupostos recursais e eventual necessidade de garantir-se o contraditório.

Outrossim, em atenção ao disposto no §3º do art. 1.010 do CPC/2015, que retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC/2015.

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, § 2º, CPC).

Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Publicada, registrada e intimadas as partes, automaticamente, via sistema.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO ELY FONTELA, Juiz de Direito**, em 21/11/2022, às 17:4:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10021578098v31** e o código CRC **d2858156**.

---

1. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. ↩
2. Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; ↩
3. https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=COL&sequencial=156083468&formato=PDF&formato=undefined ↩